

Krankheit	Anamnese	Status	Prozedere / Untersuchungen	Therapie	Kommentar
Reiseberatung	Gebiet, Dauer, Reise-Art, Unterkunft, welche Impfungen bereits gemacht, welche zusätzlich nötig Mögliche Impfungen: Hep. A, Hep. B (falls Sex), Gelbfieber, Zecken-FSME, Meningitis, Typhus, Rabies, Japan. Enzephalitis, Cholera, Influenza Malaria: Chemoprophylaxe od. Notfall-Th. Basisimpfungen aktuell? Tetanus, Diphtherie, Polio, MMR, Hep. B, Varizellen falls nicht durchgemacht			Notfall-Apotheke Impfungen Jet-Lag (Schlafhygiene, Melatonin) Safer Sex Sonnenschutz Mückenschutz Hygiene (H2O-Desinfektion ev., Peel/Cook/Boil-it) Thrombose-Prophylaxe falls RF's (Kompressionsstrümpfe, Fraxiparinspritze)	Notfall-Apotheke Übelkeit >Motilium, Allergie >Adrenalin/Anthihistaminika, Schlafstörung >Stilnox, Baldrian, Durchfall>Immodium, Hals-Sz. >Mebucaine, Wundversorgung >Gazen + Betadine + Pflaster, Schmerzen/Fieber >Dafalgan/ASS/Voltaren, Magen-Darm-Krämpfe >Spasmo-Canulase, Mückenstiche >Antibrumm, Darmflora >Bioflorin, Durchfall mit Fieber >AB/Chinolone
Müdigkeit	Seit wann, Intensität, Leidensdruck, Schlafrhythmus, <u>Schlafhygiene</u> (Einschlafen, Früherwachen, Anz.h/Tag, Apnoe, Schnarchen), <u>Hypothyreose</u>-Symptome (Gew.zunahme, Depression, Haarausfall, Obstipation, trockene Haut, Kälte...), <u>Anämie</u>-Symptome (Haarausfall, Rhagaden, Dyspnoe, Leistungsminderung, Nagelprobleme), <u>Ernährung</u>, <u>Fieber</u>, <u>B-Symptome</u>, <u>Erkrankungen</u> (Herz, Lunge, endokrin), <u>PA</u>, <u>FA</u>, <u>Medikamente/Drogen</u>, <u>Soziales/Psyche</u> (Depression/Antrieb)		Internist. Status (Blässe, Fieber, Gewicht, Herz, Lunge, Abdomen..) Falls >4 Wo. + unerklärbar: BE (BB, LC, CRP, BSR, Elektrolyte, Ferritin, BZ, Leberwerte, Kreatinin, B12/Folat, TSH, Albumin, ev. HIV + Serologien). U-Status, Thorax-Rx, ev. EKG	Je nach Ursache und: Schlafhygiene*, Sport, Medi-Wechsel, Muskelrelaxation n. Jacobson, Psychoth., ev. Antidepressiva)	DD: Endokrinologie (Hypothyreose), Anämie, Medis, Tumor, Infekt, Psyche/Depression, Schlafstörung *Immer selbe Zeiten (inkl. WE), kein Mittagsschlaf, nicht zu lange im Bett bleiben, Einschlafritual, Sort, Kein Essen vor Schlaf, keine Uhr im Zi., kühle Temp., etc.
Medi-Gespräch	Welches Medi wofür, Compliance, NW, Allergien, Besserung Werte, NW auf Beipackzettel richtig interpretieren	Parameter Kontrollieren Gezielter Status (je nach Medi)	Ev. BE Medi-Plan erstellen + ev. Medis anpassen Instruktion Einnahme	1. Medi-Plan 2. Compliance	
Rauch-Stopp	Abusus-Anamnese (wie lange, wieviel, welche Situationen, Auslöser/Trigger), Psyche, Soziales, Wunsch des Pat., Pat. überzeugen (Folgen des Konsums, bereits eingetretene Symptome),	Gewicht messen	Strategie erarbeiten: - Vertrag - Jeden Tag 1 Zigarette weniger - Belohnung - Geld auf Seite tun	1. Vertrag 2. Regelmässige Kontrollen 3. Strategie 4. Nicorette-Pflaster, Champix (Nikotin-Agonist) 5. ev. Andidepressivum	Informieren, dass Gewichtszunahme kurzfristig, langfristig aber nicht
Alk-Stopp	Unterstützung bieten, Ziele erarbeiten, Vertrag	Besprechen ob stationär od. ambulant od. via HA mit engmaschigen Kontrollen	BE (Leberwerte), ev. Haarprobe Strategie erarbeiten: -Vertrag - Soziale Unterstützung - Belohnung - Geld auf Seite tun - Kein Alk vor Abendessen >Alk nur am W-End,	1. Vertrag 2. Kontrollen (Alk-Test), ev. Haarprobe 3. Strategie 4. Benzodiazepine 5. ev. Andidepressivum	Falls via HA od. ambulant sofort melden bei Entzugsproblemen/Delir

Präp-Abklärung	Siehe Chirurgie-Szenarien				
Anämie	Symptome: Müdigkeit, Leistungsabfall, Kopf-Sz., Atemnot, Blässe, Tachykardie, Rhagaden, brüchige Nägel, neurolog. Störungen Ursachen: Blutverluste (Stuhl, Urin, Mens, oral), Operation, Ernährung (Vitamine, Vegi), B-Symptome, FA, Medikamente, Infekte/Fieber, Kriterien: Hb, EC's od. Hämatokrit zu tief	Inspektion (Blässe, Rhagaden, Fingernägel, Hämatome) Kardiostatus (Tachykardie, Systolikum ev.) Lunge Abdomen	Labor (Hb, Hämatokrit, MCV, Retis, Th, CRP, Serum-Fe, Transferrin-Sätt., sTfR, Ferritin, B12, Holo-TC, MMA, Folat, Kreatinin, LDH, Bilirubin) Ausstrich (bei V.a. Sichelzell- od. Kugelzell-Anämie, B12 ev.) Hämocult-Test (V.a. Blutverlust) Allenfalls gynäkolog. Abklärung Retikulozyten betrachten (hypo- od. hyperregenerat. A.)	Ursache beheben <u>Fe-Mangel</u>: Tardyferon-Tbl. * (II-wertiges Fe, 1x nüchtern mit O-Saft, falls GIT-Probleme nach Essen), bis 3-6 Mte., Blutkontrolle nach 1-2 Wo. (Anstieg) <u>B12/Folat</u>: Substitution: Folat-Tabl. (1/d), B12-Depot-Spritze (alle 3-6 Mte. i.m.) z.T. KM-Transplantation nötig (<u>Thalassämien, Sichelzellanämie, ev. bei aplast. A.</u>) <u>Sphärozytose</u>: Splenektomie *NW: GIT-Probleme,	Mikrozytäre hypochrome A (Fe-Mangel-A. >Fe, Zöliakie, Malabsorption, kein Ileum; Thalassämie > zu viele aber kl. EC's, MCV tief (Mittelmeerraum)) Normochrome Normozyt. A. (Blutverlust, Hämolyse, renale A., aplast. A.) Makrozyt. Megaloblast. A. (B12, Folat-Mangel) Makrozyt. Hyperchrome A. (Alk, Chemo, B12, Folat..) Sichelzell-A.: halbmondförmige EC's (Mutation), Infarkte, etc. Sphärozytose/Kugelzell-A: Störung Zytoskelett, kugelige EC's, Problem Zytoskelett
Kopfschmerzen	Dauer, Sz-Typ, (pulsierend, dumpf, Spannung), Intensität, Zeitverlauf, bi- od. unilateral, Lokalisation, Ausstrahlend (Augen-Sz., Gesichtsz.), Begleitzeichen (Photophobie, Sehstörungen, Nausea, Emesis, Augentränen), lindernde + verstärkende Faktoren, Aura (Lichtblitze, sensible Störungen, Sprachstörungen..), Fieber, Schlaf, Müdigkeit, Schwindel, AZ, Krankheiten, FA Trigger: Schlafentzug, Medis, Dehydratation, Stress, Psyche, Trauma, Erkrankungen	Inspektion Palpation (A. temporalis, Nackenmuskulatur, Sensibilität Trigemini, NNH) Neurostatus	Selten MRI *Bei allen, Tagebuch, Biofeedback, Entspannung, Stressreduktion, regelmässiger Schlaf, Akupunktur	Migräne - Verhaltenstherapie (Tages-+ Schlafrhythmus regulieren, kohlenhydratreiche Ernährung), Bio-Feedback/Autog. Training - Medi bei Attacken: Antiemetikum, Aspirin/Dafalgan - Schwere Attacken: Triptane <u>Clust-Kopf-Sz</u> O2, Triptane, ev. Lidocain nasal, Rest unwirksam <u>Spannungskopf-Sz</u> Aspirin, Paracetamol Antidepressiva/Remeron falls chron.	Migräne: rezidivierend, Attacken 4-72h, einseitig, pulsierend, Begleitzeichen, ev. Aura, Spannungskopf-Sz.: ganzer Kopf, relativ stark, wenig Begleitz. Clusterkopf-Sz.: einseitig im Bereich Schläfe + Auge, extrem stark, Tränen, Konjunktivitis Neuralgie: E. Trigemini Sekundäre Kopf-sz.: Folge einer anderen Erkrankung, z.B. Trauma, Gefässerkrankung, Hypertonie, etc. Triptane: sel Serotonin-Rez. Stimul., Almo- od. Eletriptan z.B.
Fieber	Kältegefühl, Schüttelfrost, Tachykardie, Husten, Atemnot, Halsweh, Schnupfen, Schmerzen (Kopf, Throat, Ohren, Abdomen), Erbrechen, Diarrhoe, Dysurie, Athritis, Tagesschwankungen, Messmethode, Exanthem, Juckreiz, AZ/Verhalten, Schlaf, Urin/Stuhl, Appetit, B-Symptome	Neuro: Meningismus prüfen (Nackensteifigkeit, Kernig/Lasegue-mässig), Pupillen, Sens., Hirnnerven AZ: Peripherie warm? Farbe, Turgor/Schleimhäute, Verhalten HNO (Mundhöhle, Rachen, Ohr), Lunge Haut (Exanthem) GIT/Abdomen Nierenloggen Lymphknoten	Vitalparameter (Puls, BD, Peripherie), Fiebertemperaturen BE (BB, BSG, CRP, LK, + je nach Verdacht) + Serologien U-Status + Urinkult (bei HWI + Bauchorgane) Mikrobio (Sputum, Urin, Blut, Stuhl, LP, etc.) NPS, Rachenabstrich, Streptotest, bei V.a. auf Infekt obere Atemwege	1. Ursache behandeln 2. Antipyretika (Dafalgan, Aspirin) 3. Genug Trinken, Bettruhe Sepsis-Workup wenn: akut hohes Fieber + kein Infektfokus + ev. schlechter AZ >BE (CRP, Blutbild), Blutkultur, Th-Rx*, U-Status, LP* *nur wenn schlechter AZ	DD: Infekt obere Atemwege, Fieberkrampf, Pneumonie, Gastro-E./GIT, HWI/Pyelonephritis, O. media/Mastoiditis, Osteomyelitis, Endokarditis, Malaria, Tumor, Meningitis, Sepsis.... <u>Status febrilis:</u> >7 T. NPS: eher f. Viren, Rachenabstrich (bakt.), Streptotest (Strep. A) <u>3-T-Fieber:</u> meist zw. 6-24 Mt., Herpes-Virus, nach 3T. Fieber

	Trigger: Kranke in Fam./Umfeld, Kinderkrankheiten, AUSLANDREISE, TIERE, MEDIS, Erkrankungen,	Gelenke	LP bei V.a. auf Meningitis Ev. Bildgebung (US bei inneren Organen, TEE bei Endokarditis, CT bei Mastoiditis, Rx bei Pneumonie, Szinthe bei Osteomyelitis)		Exanthem, selbstlimitierend, sympt. Th.
Diabetes	Gewichtsverlust, Durst, Polyurie, Ernährung, FA, Wunden, Müdigkeit, Sehstörungen, Infekte, Sensibilitätsstörungen, Angina Pect., pAVK, CVI RF's: DM, Hypertonie, Dyslipidämie, Adipositas, +FA, Bewegungsmangel, Alkohol, Rauchen	Weitere RF's ausschliessen: BD-Messung, Gewicht, Lipide (BE) Inspektion (Füsse, Durchblutung in Peripherie) Visus-Prüfung Grober internist. Status ev.	Nüchtern-Glucose (<7) Labor (HbA1C, Kreatinin, Albumin, Ketonkörper) U-Status (Glucose, Mikroalbumin, Ketonkörper, pH, Osmolarität)	1. BZ-Messungen > Profil erstellen 2. Lifestyle (Sport, Gewichtsreduktion, Diät, CV-RF's) 3. erst dann orale Antidiabetika (Metfin) + Aspirin (denn DM ist CV-RF!) 3. Insulin Kontrollen: Augenarzt, Podologe, Nephrologe,	Kriterien: 2x erhöhte (>7 mmol/l) Nü-Glucose HbA1C: <6.2%
Polyneuropathie	Distal betonte symmetrische Ausfallerscheinungen, red. Sensibilität, Parästhesien, Gangunsicherheit, Stürze, Verletzungen, nicht-heilende Wunden/Infekte, HWI's, Impotenz, Trigger: Alkohol, DM, B12/Folat-Mangel, Medikamente....	Inspektion Neurostatus: Reflexe (Areflexie), Kraft (ev. red.), Sensibilität (reduziert), Vibration (Stimmgabel), Lagesinn, Temperatur, Knie-Hacke/Romberg/Unterberger Gang-Testung Internist. Status	Labor (B12, Folat, Kreatinin) BZ-Messung Nervenleitgeschwindigkeit	Je nach Ursache <u>Alkohol:</u> Stopp + B1-Gabe <u>B12/Folat:</u> Substitution <u>DM:</u> gut einstellen, s. oben <u>Bei allen:</u> Antiepileptika, Antidepressiva TEN	Stimmgabel: <5 = Patholog. Bei Prüfung Sens., Lagesinn +Temp. soll Pat. Augen schliessen Nicht-Opioide wirken oft nicht. TEN: Transkut. Elektr. Nervenstimulation
Diabetischer Ulkus	Anamnese s. DM + Polyneuropathie DD: dekubitales, venöses od. arterielles Problem!	Inspektion: Druckstellen (Metatarsale-Köpfchen oft) Neurostatus (Sens., Mot., Reflexe, Vibration, Lage) Gefässstatus: Fusspulse, Rekap., Wärme, Auskult. LK	Abstrich (Infektausschluss), Biopsie (falls Ulkus >2-3 Wo.) Ev. RX/MRI (Knochenbeteiligung) Interdisziplinär: Angio, Gefässchir., Derma, Innere/Diabet.	1. Kürettage, Salbe, Verband 2. AB falls Infekt 2. Art. Durchblutung sanieren: PTA, Bypass 3. Chirurg. Falls Osteomyelitis 4. Druckentlastung/ Spezialschuhe 5. DM einstellen	Ergänzungstherapie - AB falls Infekt - Chirurgie falls Osteomyelitis - ev. Vakuumverband - ev. Wunddeckung mit Spalthaut, Vollhautlappen od. autolog. Saugblasen
Art. Hypertonie	Wie war BD bis anhin, bisherige Dx od. Th, Kopf-Sz., Ohrenrauschen, Herzklopfen, Atemnot, Schlaf (Apnoe), Medis, FA RF: Nierenprobleme, Rauchen, DM, Adipositas, Dyslipidämie, +FA, Bewegungsmangel, OSAS	Herz, Lunge Auskultation Abdomen Pulsstatus	Labor (Elektrolyte, Kreatinin, BZ, Lipide) BD-Messung (li. + re.), ev. ambulante 24h-Messung Puls Weitere RF's ausschliessen! >Gewicht, Lipide (BE)	1. BD-Messgerät > Profil 2. Lifestyle (Sport, Gewichtsreduktion, Diät*, Stress, RF's*!!) 3. Medis. Zuerst Mono-Th. (Diuretikum/ Torem) + dann später ev. 2. Medi (Ca-Kanal-Blocker/ Nifedipin , ACE-Hemmer/ Enalapril od. B-Blocker/ Metozero)	Kriterium: >140/90, mind. 3x an 2 versch. Tagen Isolierte Systol. H: Ca-Kanal-Bl. M.d.W. Falls s. hoher BD direkt Medi geben *Wenig Salz, mediterrane Kost, kein Kaffee, kein Nikotin, wenig Alk

Adipositas/Hypercholesterinämie	Essverhalten, Befindlichkeit, Sport, Red. Leistungsfähigkeit, Dyspnoe, Gelenk-Sz., Schweissneigung, Psyche RF: DM, Hypertonie, Dyslipidämie, +FA, Bewegungsmangel, Alkohol, Rauchen	BMI-Messung /Gewicht + Grösse Bestimmung Fettverteilungstyp (android, gynoid, lokalisiert), Haufaltendicke, Tallienumfang Weitere RF's: BZ-Messung, BD-Messung, Nüchtern-BE (Lipidstatus), Ausschluss hormonale Störung (oGTT, TSH, Dexamethasontest)	1. Lifestyle (Diät/Ernährungsumstellung, Bewegungstherapie) 2. Verhaltenstherapie bei Adip. (Stressabbau, Erlernen natürl. Hunger-Sättigungsverhalten) 3. Medis bei Hypercholesterinämie: Sortis /Atorvastatin, ev. Cholestyramin/ Lipocol , 4. Medis bei Adipositas: Orlistat , 5. Psychologie (ev. Essstörung) 6. Ultima-Ratio: Chirurgie >Bypass, Magenband, u.a.	Adipositas: BMI >30 Übergewicht BMI >25 Lipidstatus: Gesamt-Cholesterin, HDL- + LDL, TG's LDL-Cholest.: <4.2 mmol/l HDL-Cholest.: >1.0 mmol/l TG: Gesamt-Cholesterin:
Asthma	Siehe Pädi-Szenarien			
Infekt obere Atemwege/Erkältung	Trocken, Feucht, Sz., Auswurf, bellend, Schnupfen, Halsweh, Ohrenweh, Fieber, Schüttelfrost, AZ, Kopf-Sz. (beim Bücken), NAB/Dyspnoe, Hyposmie, Allergien, Reise-Anamnese	Lunge: Auskult. + Perkussion HNO: Ohren, Nase/Sinus, Rachen/Mund/Zunge Lymphknoten Haut (Exanthem) Meningitis-Zeichen	BE (CRP + LK), Fiebermessen <u>Schnupfen</u> NPS <u>Angina/Tonsillitis</u> od. Pharyngitis Abstrich + Streptotest <u>Mononukleose</u> BE (Leberwerte + LZ), Serologie (IgM) <u>Scharlach:</u> Streptotest Bei RS keine BE nötig, fast immer viral	CRP + LK normal >viral od. Mononukleose >symptomatische Therapie - Husten: Sirup (Solmucalm > Codein + Acetylcystein) - Halsweh: Lutschtabletten, Spray, Gurgeln - Schnupfen: Otrivin, Steroidspray, NaCl -Spülungen - Generell/Fieber: NSAR, Paracetamol - Allergisch: top. Steroide od. top. Antihistaminikum <u>CRP + LK hoch >bakteriell od. wenn Streptotest positiv</u> - AB + sympt. Th.
Hals-Sz.	s. HNO	DD: Mononukleose	Streptokokken-Angina/Tonsillitis	Virale Pharyngitis
Husten/Pneumonie	Husten, Fieber, Schüttelfrost, red. AZ, Atemnot, Atemnotzeichen, Thorax-Sz., eitriges od. rotbraunes Sputum, Arthralgien, Myalgien, Reisen, Allergien	Lunge: Auskultation (Bronchialatmen, RG's), Perkussion (Dämpfung), post. Bronchophonie (66 flüstern) , Stimmfremitus (99 sprechen) pos. <u>Herz</u> <u>LK</u> <u>HNO</u> <u>Meningitiszeichen</u>	Vitalparameter (Biox, BD, Puls) + Fieber messen Labor (CRP, LK, Hämat., BSG, Procalcitonin) Rx-Thorax, ev. US (Erguss) aBGA ev. Sputum (Erregernachweis) Blutkultur (falls hospitalisiert) Selten Bronchoskopie	1. Ambulant wenn: <65, guter AZ, keine Begleiterkrankungen + Komplikationen, Rest Hospitalisation 2. Augmentin 7-10 T.* Bettruhe, ev. Thrombose-Prophylaxe, Atemgymnastik, NaCl-Inhalationen, O2, Infusion 3. Kontroll-Rx
COPD	Chronische Bronchitis mit Husten + Auswurf, morgendliches Aushusten v. Sputum, Belastungsdyspnoe, oft Infekte RF: Rauchen/Passivrauchen, Abgase, Noxen	<u>Lunge: Auskultation, Perkussion</u> Bronchophonie (66 flüstern) , Stimmfremitus (99 sprechen) <u>Herz</u> <u>LK</u> <u>HNO</u>	LUFU aBGA CO-Bestimmung in Ausatemluft (Raucher) Sputumkultur + Antibiotogramm Rx-Thorax	1. Noxen/ Nikotinstopp 2. Immunisierung (Pneumovax, Influenza-Impfung, H. infl. Typ B, Bronchovaxom) 3. Atemtraining + Körpertraining 4. Medis: B2-Memetika, Anticholinergika 5. O2
LE / TVT	TVT: Bein-Sz., Schwellung, Rötung, Spannungsgefühl, Besserung bei Hochlagerung, ev. Blau, Überwärmung, ev. Fieber LE: Dyspnoe, Tachykardie, Thorax-Sz., Angst, Beklemmungsgefühl, Husten, Schweiss, Schock, Synkope, Hämoptyse	AZ (Blässe, Zyanose, Tachypn.) Beine untersuchen: Inspektion, Rekap., Durchblutung (Rekap., Wärme), Pulse, Meyer-Zeichen, Homans-Zeichen, Ballotement, Druckempfindlichkeit) Neurologische Untersuchung Beine (Kraft, Sens., Motorik,	LE: Vitalparameter Labor: D-Dimer, Quick, Hämat., CRP, LK, BNP + Troponin, Gerinnungsstörungen >FV-Leiden, Protein-C/S-Mangel, etc.) aBGA EKG (Sinustachykardie, Rechtsherzbelastung)	LE 1. Hospitalisation, Bettruhe, O2, ZVK 2. Fraxiparin (falls haemodyn. Stabil)*+ dann OAK/Marcoumar 3. Fibrinolyse/ Streptokinase (falls massive LE + instabiler Pat.) 4. Thrombolyse via Katheter
				DD: TVT, pAVK, Neurolg. Problem, Compartment-Sy Dauer: 3 Mt. falls RF (Ops, Reise, etc.), 3-6 Mt. falls kein RF od. wenn Thrombophilie, unbegrenzt wenn rezidiv. Thrombo-Embolien od. Krebs

	RF: TVT, Gerinnungsstörung, Varizen, Immobilisation, Ops, Gips, Reisen, Rauchen, Pille	Reflexe) Lunge (Auskultation >RG's ev.; Perkussion, Atemfreq.) Herz	CT-Angio , ev. Perfusions-Szinthi Farbduplex-Sono: Nachweise TVT TVT: Vitalparameter, Labor, Farbduplex-Kompressions-Sono Beinvenen, ev. CT-Phlebographie	5. Embolektomie (chirurgisch) TVT: Kompression Wade, kein Bettruhe nötig, nicht Pressen (>LE), kein Wärme, Fraxiparine -Spritzen od. OAK/ Marcoumar (Heparin aber bis bis an mind. 2 T. INR >2), oder Fibrinolyse/ Streptokinase	Mayer: Sz. bei Wadenkompress. Homan: Sz. bei Extension Fuss
Thorax-Sz. / ACS / KHK	Siehe Chirurgie-Szenarien				
Herzinsuffizienz	Rechtsherz: Gewichtszunahme, Ödeme >Nykturie, Leber-Sz., Ikterus, Bauchumfang (Aszites), Gastritis, Linksherz: Dyspnoe (Aufsitzen hilft), Tachypnoe, Husten, schaumiger Auswurf, Zyanose, Nykturie Beide: Leistungsminderung, Müdigkeit, Erschöpfung, Nykturie, Tachykardie, HRST, feucht-kalte Haut	Inspektion (Zyanose, Fingernägel, Ödeme an hängenden Körperstellen, Durchblutung, Peripherie, Halsvenen, Ikterus) Kardiotatus (Auskultation >ev. 3. HT, HRST; Schwirren, Spitzenstoss, Pulse, Ödeme, Zyanose) Lunge (Dyspnoe, Tachypnoe, basale RG's, Atemhilfsmuskeln) Abdomen (Hepatomegalie, Leber-Sz.)	Vitalzeichen (tiefer Biox, Tachykardie, Tachypnoe, BD) NYHA-Stadium bestimmen Labor (BNP) Echo (EF-Bestimmung, Kardiomegalie, HMV, diastol./sytol. Dysfunktion) EKG (HRST, Infarkte) Rx-Thorax (Kompensation) *erst ab NYHA III	1. Ursächliche Th. (Hypertonie, KHK, RF's, Kardiomyopathie, HRST, Vitium...) 2. Lifestyle: RF-Therapie, Physio/Sport (falls decomp. HI >Bettruhe), leichtverdauliche Kost mit wenig Salz + viel Kalium, Flüssigkeitsbegrenzung, Thrombose-Prophylaxe, ev. O2 3. Medis: Enalapril /ACE-Hemmer, Valsartan /AT-Rez-BI., Beloc-ZOK /B-Blocker, Aldactone /Aldosteronantag. *, Digitalis * 4. HTX wenn terminale HI (NYHA IV)	<u>Def:</u> Unfähigkeit des Herzens des Herzzeitvol. Bei normalem enddiastol. Ventr.druck zu fördern. <u>Oft Globalinsuff.</u> (li. + re.) <u>Normale EF</u> >55% <u>NYHA-Stadium</u> (I Keine Einschränkung, II bei stärker Belastung, III bei leichter Belastung, IV in Ruhe) <u>Rx-Li-Herz-Insuff:</u> L-Ödem, Kerley-B-Linien (verdickte Interlobärsepten) weil Ödem, gestaute Hilusgefäße, verbreiterte Lungenvenen, ev. Pleuraerguss, Herzhypertrophie <u>Rx-re-Herz-Insuff:</u> Verbreiterung v. Azytos + V. cava + re. Vorhof, Hypertrophie Herz
GERD	s. Chirurgie-Szenarien				
Magenulkus	s. Chirurgie-Szenarien				
Bauch-Sz.	Schmerzen (7 Dimensionen genau erfragen, Sz/Erleichterung bei Stuhlgang, etc.), AZ, Schonhaltung, Schlaf, Fieber, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, Wind, Blähung, Stuhl- + Urin, Blutverluste, Appetit, Ernährung, Kopf-Sz., Schwindel, Arthritis, Gewichtsverlust, nächtliches Erwachen, B-Symptome, Wachstumsrückstand Trigger: Trauma, Medis, Kinderkrankheiten, Umfeld krank, Psyche/Soziales/Schule, Verdorbene Speisen	Inspektion (Kolorit, Ikterus, Blass, Turgor) + Haut + AZ + EZ , Perzentilen Abdomen (Quadranten, Auskultation, Loslass-Sz., Meteorismus, Resistenzen, Bruchpforten, Abwehrspannung Lanz/Mc Burney, Courvoisier/Murphy, Leber, Milz, Nieren) Herz, Lunge Nieren Mund Lymphknoten Analinspektion	Schmerzskala (Smileys) PVK + Labor (Hämat., CRP, LK, Hämat., Pankreas-Amylase + -lipase, Bilirubin, ALP, γ-GT, Kreatinin, Tropoin, CK-MB) US, EKG, Rx-Leer (stehend od. li-Seitenlage), Thorax (ap stehend) Ev. CT	Unklare Ursache: Verlaufsbeobachtung + Schmerzprotokoll, ev. Ernährungsberatung	
Akutes Abdomen	s. Chirurgie-Szenarien				
Pankreatitis	s. Chirurgie-Szenarien				

Hepatitis/ Leberzirrhose					
Gastroenteritis/ Durchfall	s. Paedi-Szenarien				
Obstipation	Pressen f. Defäkation, harter Stuhl, Gefühl unvollständige Entleerung, manuelle Unterstützung, < als 3x pro Wo., Verdauung, Magenbeschwerden, Erbrechen, Übelkeit, Urin *	Abdomen Rektaluntersuchung *Trigger: Ernährung/Kost, zu wenig Trinken, Mangel an Fasern, Medis (Opiate, TCA, etc.), Darmerkrankung, Hypothyreose, Stress/Psyché, mangelnder Sport	Labor (Elektrolyte, TSH, Hb, CRP, LK) Hämocult-Test Ev. Koloskopie Ev. US Ev. Abdomen-Leer (bei V.a. Ileus) Kolontransitzeit messen (selten) Defäkogramm, Sphinctermanometrie, etc.	1. Ursache behandeln 2. Ernährungsumstellung* 3. Ballaststoffpräparate (Leinsamen u.a.), Laxantien/Lakulose (kurzfristig) 4. Bauchmassage, 1 Glas kaltes Wasser nüchtern (gastrokol. Reflex)	<u>*wenig Weissbrot, Schokolade, Schwarztee, Kakao + Rotwein, viel Ballaststoffe</u> (Gemüse, Früchte, Salat, Getreide, Vorkornbrot, getrocknete Pflaumen, Datteln, Feigen) + viel <u>Flüssigkeit</u>
Zöliakie, Lactoseintoleranz	Zöliakie: urchfall, Gewichtsverlust, Mangelerschienungen (Fe-Mangel >Rhagaden, Müdigkeit, Dyspnoe, Nägel), Gedeihstörung, Zungenbrennen, rote Zunge, Osteoporose, Arthritis, L-Intol: Diarrhö, abd. Sz., Blähungen, Flatulenz, oft nach Genuss v. Milchprod. *	Abdomen *bei beiden Fragen: Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen, Müdigkeit, Gewichtsverlust, B-Symptome, Flatulenz, Blähungen, etc.	Zöliakie: IgA-Gliadin-AK, IgA-anti-Transglutaminase, ev. US, Biopsie (Dünndarm) L-Intol: H2-Atemtest nach Gabe v. Lactose, selten Gentest +/-od. Biopsie	Zö: lebenslang glutenfreie Diät* , Substitution falls Mängel L-Intol: Ernährungsberatung >je nach Schwere des Mangels laktosefreie od. –arme Diät**. Ev. orale Zufuhr v. Lactase vor Konsum v. Milchprod.	Zö-Dx: Klinik, AK + Biopsie *Kartoffeln, Mais, Hirse, etc. KEIN WEIZEN/Gerste/Roggen/Dinkel **Butter + Käse prakt. keine Lactose. Joghurt, Quark, Buttermilch etc. nur wenig Lactose
CED	s. Chirurgie-Szenarien				
HWI /Pyelonephritis	s. Gyni-Szenarien				
Prostata (BPH, Prostatitis,Ca)	Nykturie, abgeschwächter Strahl, Pressen, Nachträufeln, verzögertes Urinlassen, verlängerte Miktionszeit, Harndrang, Infekte, Leidensdruck, Hämaturie? Schmerzen? Sexualität, B-Symptome, AZ	Prostata-Palpation (inkl. Sphinctertonus + Analreflex) Nierenloggen	Labor (PSA, Kreatinin, CRP + LK falls Prostatitis-Verd.) Ev. Urin-Status (Zystitis od. Prostatitis-Ausschluss) US (Restharnbestimmung + Niere) Bei V.a. Ca Biopsie Ev. Urogramm + Urodynamische Tests	BPH: *5a-Reduktase-Hemmer/ Finasterid , Anticholinergika , a1-Drenozeptorantagonisten , Chirurgie: TUR-P, Enukleation Prostatitis: AB, Analgesie, ev. DK Ca: je nach Staging >Ops, RT/Chemo, Watchful-Waiting	5a-Red-Hemmer: blockieren Bildung v. DHT (potenter) aus Testosteron Anticholinergika: Abnahme Muskeltonus Blase *Ev. Hausmittel: Kürbissamen, etc.
Rückenschmerzen / Diskushernie / Lumbago / (Pseudo-) Radikläres Sy	S. Chirurgie-Szenarien				

Problem mit Bewegungsapparat	Schmerzen: Intensität, Typ, Lokalisation, Ausstrahlung, Lindernde + verstärkende Faktoren, Begleitzeichen; Übelkeit, Erbrechen, Kopf-Sz., Sensibilitätsausfälle/Parästhesien, Kraftverlust, Sport/Gang, Gelenk-Sz., sonst gesund (Herz, Lunge), FA, Medis,	Untersuchung Bew-Apparat: - Inspektion (Gelenksachsen, Schiefstand, Trophik, Schwellung, Rötung, Überwärmung, Durchblutung, etc.) - Spezifische Tests* - Gelenke (aktiv + passiv, Druckdolenzen, Beweglichkeit >Goniometer) - Bänder (aktiv testen) - Sehnen/Muskeln (Palpation, Kraft messen gg. R, Reflexe, Tonus) - Knochen (Palpation) - Sensibilität/Dermatome (ev. Vibration, Lage- + Wärmesinn) - ev. Neurostatus (Hirnnerven, Romberg, Knie-Hacke, FNV, Diadochokinese) - Gang	Sehnen, Gelenkserguss: US Weichteile V.a. Fraktur: Rx V.a.Neurales od. Weichteilproblem (Menisken, Bandscheiben, etc. > MRI)	Chron. Arthritis: Infiltration mit Cortison , ev. Hyaluronsäure , ev. Th-Konzentrat , Analgesie E. od. Myopathie: Voltaren , Kühlung ALLE: Physio, Massage, Training/Sport, Akupunktur, NSAR , selten Opiate , ev. TEN , ev. autog. Training	Dermatome + Reflexe anschauen! * Knie: Achsen, Erguss, Patella, Hyperext., Flexion, Mc Murray, Peyer-Zeichen/Schneidersitz, Gelenkspalt palpieren, Varus- + Valgusstress, vordere + hintere Schublade, 1-Beinstand + Rotation im Knie Hüfte: Impingement-Tests, Innen- + Aussenrot., Flex., Ext., Abd- + Adduktion Schulter: Impingement-Tests (Elevation + in Abd. Innenrot. machen >auf Sehne/Gelenk drücken), Schürzengriff, Cross-Body-Sign, Nackengriff, etc. OSG/USG: Flexion, Ext., Supp., Pron., Rot., Schublidentest, Thomson-Test Rücken: Re- + Inklination, Rotation, Seitneigung, Kinn-Sternum-Abstand, Finger-Boden-Abstand, Lot fällen, Lasegue Hand: Tabatiere (Scaphoid-Fx), Rest siehe Bewegungsapparat-CST
Arthrose	Schmerzen: Intensität, Typ, Lokalisation, Ausstrahlung, Lindernde + verstärkende Faktoren, Begleitzeichen, Kopf-Sz., Anlauf-Problem, Morgensteifigkeit, Nacht-Sz., Muskel-Sz., Wetterfühligkeit, Krepitation, Bewegungseinschränkung, Gelenkschwellung, Fehlstellung, Sensibilitätsausfälle/Parästhesien, Kraftverlust, Sport/Gang, übermässige Belastung, sonst gesund (Herz, Lunge, Rheuma, Systemerkrankungen), FA, Medis	Inspektion (Atrophie Muskulatur, Schwellung, Fehlstellung, etc.) Palpation (Erguss, Knochenplus, Schwellung, Warm-Kalt) Bewegung pass. + aktiv (Goniometer) Spez. Tests , etc. (s. oben)	US, Rx (Osteophyten, Geröllzysten, Gelenkspaltverschmälerung, subchondr. Sklerosierung), MRI DD: Arthriti >CRP + Rheumafaktor	1. Lifestyle: Gewichtsreduktion , Belastung reduzieren (im Mass), Weiche Schuhe (Puffer), Schwimmen im warmen Wasser, Bewegungsth./Physio, 2. Medis: Paracetamol, NSAR (nur befristet), ev. Cortisol-Infiltration 3. Chirurgie (Arthroskopie, Prothetik)	Heberden- vs. Bouchard-Arthrose, Rhizarthrose (Daumensattelgelenk), Gonarthrose, Coxarthrose
Fazialisparese	Siehe ORL-Szenarien				
Synkope	Wie lange Bewusstseinsverlust, Sz. vor Augen? Sturz? Schwindel, Kopfsz., tiefer BD? Nicht gegessen/getrunken? AZ, beim urinieren? Erkrankungen Herz? Medis	Neurostatus Internist. Status (v.a. Kardiostatus) Fremdanamnese!	Labor (D-Dimere, BNP, Elektrolyte, Tox-Screening, Gerinnung) EKG, Vitalzeichen Schellong-Test BZ Ev. Echo	Orthostatische S.: Flachlagerung + Beinhochlagerung, Hydratation Vasovagale S.: lernen Prodromi zu erkennen + s. hinzusetzen od. via Hendrassik-Handgriff z.B. zu vermeiden Arhythmogene S.: ev. Schrittmacher nötig, Th. HRST	Ursachen: vasovagal, orthostatisch, kardial/vaskulär Def: plötzlicher spontaner reversibler Bewusstseins- + Tonusverlust weil ZNS-Minderperf.

TIA / TGA / CVI	TGA: akut beginnende anterograde Gedächtnisstörung(immer wieder selbe Fragen), mind. 1h, max. 24h, Orientierungsstörung, Bewusstsein meist ok TIA: Seh- + Sprachstörungen, Sensibilitätsausfälle auf 1 Seite Gesicht od. Körper (Hemi-Sy.), nur kurz, max. 24h CVI: „“ aber >24h, Ataxie, Schwindel, ev. Kopf-Sz., Erbrechen	TGA: keine Befunde im Neurostatus, keine Dx nötig TIA/CVI: O2, Vitalzeichen (BD li. + re., Puls, Biox, EKG), PVK + BE, DK, Neurostatus (Pupillen, Orientierung, Bewusstsein, Hirnnerven, Hemi-Symptomatik >Sens., Motorik/Kraf, Reflexe, Meningismus, Sprache, Gesichtsfeld), EKG, Labor (Hämat, CRP, LK, Gerinnung, D-Dimere, Troponin, CK-MB), sofort CT/MRT-Schädel, ev. Bildgebung Halsgefäße + TEE,		TGA: keine Th. nötig, Beruhigung TIA: Th-Aggregg.hemmer/ASS + OAK als Prophylaxe CVI: - Acti-Lyse i.v. (max. 4.5h nach CVI) - Intraart. Lyse (max. 6h nach CVI) od. Katheter-Therapie (Abasaugen Thrombus) - Antikoagulation Heparin - Reha	TGA: Ursache unklar, selten Rezidive, volle Rückbildung TIA: transiente ZNS-Perfusionsstörung, bildet s. meist nach 10 min. zurück, max. 24h (sonst = CVI), in 20% Progression zu CVI! DD zu CVI nicht möglich >gleich behandeln
Alzheimer-Demenz	Konzentration, Aufmerksamkeit, <u>Orientierung</u>, <u>Gedächtnis</u>/Vergesslichkeit (Kurz- od. Langzeit, prozedural), Apathie, Verlangsamung, <u>kognitive Defizite</u>, <u>Sprachstörungen</u>, Enthemmung, <u>motor. Defizite</u> Wichtig: Bewusstsein muss intakt sein + Depressions-Ausschluss!	Eigen- + Fremdanamnese Neurolog. Untersuchung MMS, Clocktest, neuropsycholog. Tests Psychostatus (Aphasie >Sprachstörungen, Apraxie >motor. Störungen, Agnosie >Gegenstände werden n. erkennt od. n. wiedererkennt, <u>Störung Exekutivfunktionen</u> >Planen + Organisieren) Labor (TSH, Kreat., CRP, Blutbild, Elektrolyte, Leber, Glucose, B12...) CT, MRT Schädel (Atrophie, andere Pathologien ausschliessen) (selten LP: Amyloid-Peptid AB-1-42tief, Tau-Protein hoch)		1. Verhaltenstherapie, Spitex, Hintraining, Kunsttherapie 2. Medis: Cholesterinesterasehemmer (Rivastigmin, Aricept) NMDA-Antag. (Memantin)	DD: Vaskuläre Demenz, Levy-Körperchen-Demenz, Frontotemporale Demenz, Gemischte Demenz Def. Dx erst postmortem via Autopsie!
Geriatrischer Patient	<u>Demenz-Anamnese</u>, <u>ATL</u> (Essen, Körperpflege, Stuhl + Urin, An- + Ausziehen, ins Bettgehen, Mobilität), <u>Weitere Aktivitäten</u> (Einkaufen, Finanzen, Haushalt, Ernährung), <u>Wohnverhältnisse</u>, <u>Unterstützung</u>, <u>Psyche Soziales</u>, <u>Erkrankungen</u>, <u>Sturzanamnese</u>, <u>FA</u>	Internistischer Status inkl. Neurostatus (v.a. Gang, Mobilität) Psychostatus ev. (Kognition, Demenz, Psyche)	Geriatrisches Assessment nach AGAST MMS, Clocktest Psychostatus (Depression, Demenz) Get-up-and-go-Test/Mobilität Bei Sturz: Labor, EKG, Up-and-go-Test, Neurostatus, Schellong-Test, ev. CT	Anpassungen Wohnverhältnisse Mobilität: Krücken, Rollator, Böckli, Rollstuhl Familiäre Unterstützung/Nachbarn Mahlzeitendienst Spitex Alters- + Pflegeheim	<u>Fremdanamnese</u> wichtig!

